

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LIJEKA

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Octaplex 500

((14-38)+ 25 + (9-24)+(18-30)+ (13-31)+(12-32)) i.j./ml

prašak i rastvarač za rastvor za infuziju

faktor koagulacije II, humani, faktor koagulacije IX, humani, faktor koagulacije VII, humani, faktor koagulacije X, humani, protein c, protein s (humani protrombinski kompleks)

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Octaplex 500 je dostupan kao prašak i rastvarač za rastvor za infuziju koji sadrži humani protrombinski kompleks. Octaplex 500 nominalno sadrži:

Naziv sastojka	Količina po bočici 20 ml (i.j.)	Količina nakon rekonstitucije s 20 ml vode za injekcije (i.j./ml)
<i>Aktivne supstance</i>		
Humani faktor koagulacije II	280-760	14-38
Humani faktor koagulacije VII	180 - 480	9 - 24
Humani faktor koagulacije IX	500	25
Humani faktor koagulacije X	360 - 600	18 - 30
<i>Ostale aktivne supstance</i>		
Protein C	260-620	13-31
Protein S	240-640	12-32

Ukupni sadržaj proteina po bočici je 260 - 820 mg.

Specifična aktivnost lijeka je $\geq 0,6$ i.j./mg proteina, izražena kao aktivnost faktora IX.

Pomoćne supstance za koje je poznato da imaju prepoznatljivo djelovanje ili efekat: natrij (75 - 125 mg po bočici), heparin (100 - 250 i.j. po bočici, što odgovara 0,2-0,5 i.j./i.j. FIX).

Za listu pomoćnih supstanci, vidjeti dio 6.1.

3. FARMACEUTSKI OBLIK

Prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.

Prašak je plavkasto-bijele boje.

Rastvarač je bistra i bezbojna tečnost.

4. KLINIČKI PODACI

4.1. Terapijske indikacije

- Liječenje krvarenja i perioperativna profilaksa krvarenja kod stečenog nedostatka koagulacijskih faktora protrombinskog kompleksa, kao što je nedostatak uzrokovan liječenjem antagonistima vitamina K ili u slučaju predoziranja antagonistima vitamina K, kada je potrebna brza korekcija nedostatka.

- Liječenje krvarenja i perioperativna profilaksa kod nasljednog nedostatka koagulacijskih faktora II i X ovisnih o vitaminu K, kada pročišćeni lijek sa specifičnim koagulacijskim faktorima nije raspoloživ.

4.2. Doziranje i način primjene

Odobreno
ALMBIH
27.8.2026.

Doziranje

Dole su navedene samo opće preporuke za doziranje. Liječenje bi trebalo započeti pod nadzorom ljekara iskusnog u liječenju poremećaja zgrušavanja. Doziranje i trajanje nadomjesnog liječenja ovise o ozbiljnosti poremećaja, mjestu i obimu krvarenja, te kliničkom statusu pacijenta.

Količinu i učestalost primjene trebalo bi izračunati za svakog pojedinog pacijenta. Interval doziranja mora se prilagoditi različitim cirkulirajućim polu-životima raznih koagulacijskih faktora u protrombinskom kompleksu. (vidjeti dio 5.2.) Potrebna individualna doza može se odrediti samo na temelju redovnog određivanja nivoa odgovarajućih koagulacijskih faktora u plazmi ili na temelju općeg ispitivanja nivoa protrombinskog kompleksa (protrombinsko vrijeme, INR), te stalnim nadzorom kliničkog statusa pacijenta.

U slučaju većih hirurških zahvata, neophodno je precizno praćenje nadomjesnog liječenja pomoću ispitivanja zgrušavanja (test specifičnih koagulacijskih faktora i/ili opće ispitivanje nivoa protrombinskog kompleksa).

Krvarenje i perioperativna profilaksa krvarenja za vrijeme liječenja antagonistom vitamina K:

Doziranje ovisi o INR prije liječenja tjelesnoj težini. U sljedećoj tablici se nalaze približne doze (jedinice rekonstituiranog lijeka po kg tjelesne mase)

INR prije liječenja	2 - < 4	4-6	>6
Doza lijeka Octaplex (jedinice† faktora IX) / kg tjelesne težine	25	35	50

†Jedinice se odnose na međunarodne jedinice.

Doza se određuje na osnovu tjelesne težine do maksimalno 100 kg. Za pacijente teže od 100 kg, maksimalna pojedinačna doza (IJ faktora IX) ne smije prelaziti 2500 i.j. za INR od 2 - < 4, 3500 i.j. za INR od 4 - 6 i 5000 i.j. za INR > 6.

Korekcija poremećaja hemostaze uzrokovane antagonistom vitamina K traje oko 6-8 sati. Međutim, efekti vitamina K, ukoliko je primijenjen istovremeno, obično se postižu unutar 4-6 sati. Ponovljeno liječenje humanim protrombinskim kompleksom stoga obično nije potrebno kada se primjenjuje vitamin K.

Budući da su ove preporuke empirijske, a oporavak i trajanje efekta mogu varirati, obavezno je praćenje INR za vrijeme liječenja.

Krvarenje i perioperativna profilaksa kod nasljednog nedostatka koagulacijskih faktora II i X ovisnih o vitaminu K, kada lijek sa specifičnim koagulacijskim faktorima nije raspoloživ:

Izračun potrebne doze za liječenje temelji se na empirijskom nalazu da oko 1 i.j. faktora II ili X po kg tjelesne težine povisuje nivo aktivnosti faktora II ili X u plazmi za 0,02 odnosno 0,017 i.j./ml.

Doza primijenjenog specifičnog faktora izražava se u međunarodnim jedinicama (i.j.), prema trenutnom standardu SZO za svaki faktor. Aktivnost specifičnog faktora koagulacije u plazmi izražava se ili kao postotak (u odnosu na normalnu humanu plazmu) ili u međunarodnim jedinicama (u odnosu na međunarodni standard za specifični faktor koagulacije).

Jedna međunarodna jedinica (i.j.) aktivnosti faktora koagulacije jednaka je količini u jednom ml normalne humane plazme.

Na primjer, izračun potrebne doze faktora X temelji se na empirijskom nalazu da 1 međunarodna jedinica (i.j.) faktora X po kg tjelesne težine povisuje nivo aktivnosti faktora X u plazmi za 0,017 i.j./ml. Potrebna doza određuje se prema sljedećoj formuli:

**Odobreno
ALMBIH
27.8.2026.**

Potrebno jedinica = tjelesna težina (kg) x željeni porast faktora X (i.j./ml) x 60

gdje je 60 (ml/kg) recipročno procijenjenom oporavku.

Potrebna doza faktora II:

Potrebno jedinica = tjelesna težina (kg) x željeni porast faktora II (i.j./ml) x 50

Ukoliko je individualni oporavak poznat, tada tu vrijednost treba koristiti za izračun.

Pedijatrijska populacija

Nema dostupnih podataka o upotrebi lijeka Octaplex 500 kod pedijatrijske populacije.

Način primjene

Octaplex 500 treba primijeniti u venu brzinom od 0,12 ml/kg/min (~3 jedinice/kg/min), do maksimalne brzine od 8 ml/min (~210 jedinica/min), koristeći aseptičnu tehniku,

4.3. Kontraindikacije

- Preosjetljivost na aktivnu supstancu ili bilo koju od pomoćnih supstanci navedenih u dijelu 6.1.
- Poznata alergija na heparin ili trombocitopenija uzrokovana heparinom u anamnezi.
- Osobe koje imaju nedostatak IgA sa poznatim antitijelima protiv IgA.

4.4. Posebna upozorenja i mjere opreza pri upotrebi

Sljedivost

Kako bi se poboljšala sljedivost bioloških lijekova, zaštićeni naziv i broj serije primijenjenog lijeka se mora tačno zabilježiti (ili navesti) u kartonu pacijenta.

Potrebno je potražiti savjet specijaliste s iskustvom u liječenju poremećaja zgrušavanja.

Kod pacijenata sa stečenim nedostatkom faktora koagulacije ovisnih o vitaminu K (npr. induciranim liječenjem antagonistima vitamina K), Octaplex 500 se smije primijeniti samo kada je potrebna brza korekcija nivoa protrombinskog kompleksa, npr. kod većih krvarenja ili hitnih operacija. U ostalim je slučajevima obično dovoljno smanjenje doze antagonista vitamina K i/ili primjena vitamina K.

Pacijenti koji primaju antagoniste vitamina K mogu imati postojeću hiperkoagulabilnost, koju bi infuzija protrombinskog kompleksa mogla pojačati.

Ukoliko se pojave alergijske ili reakcije anafilaktičkog tipa, infuziju treba odmah prekinuti. U slučaju šoka, primijeniti standardnu terapiju za liječenje šoka.

Standardne mjere za sprječavanje zaraza koje mogu proizaći iz primjene lijekova proizvedenih iz ljudske krvi ili plazme uključuju odabir davatelja, testiranje pojedinačnih donacija i pulova plazme na specifične zarazne markere, te uključivanje efikasnih proizvodnih postupaka za inaktivaciju/uklanjanje virusa.

Unatoč tome, mogućnost prijenosa zaraznih agensa nakon primjene lijekova proizvedenih iz ljudske krvi ili plazme ne može se potpuno isključiti. To se, također, odnosi na nepoznate ili viruse koji će se tek pojaviti, te druge patogene.

Poduzete mjere smatraju se efikasnim kod virusa s ovojnicom, kao što su virus humane imunodeficijencije (HIV), hepatitis B virus (HBV) i hepatitis C virus (HCV). Poduzete mjere mogu biti ograničene efikasnosti kod virusa bez ovojnice, kao što je hepatitis A virus (HAV) ili parvovirus B19. Zaraza parvovirusom B19 može biti ozbiljna za trudnice (fetalna infekcija) i za imunodeficijentne osobe ili osobe s povećanom eritropoezom (npr. hemolitička anemija).

Odgovarajuće vakcinisanje (hepatitis A i B) preporučuje se kod pacijenata koji redovno/ponovljeno primaju lijekove protrombinskog kompleksa proizvedene iz humane plazme.

Strogo je preporučeno da se svaki put kod primjene lijeka Octaplex 500 zabilježi naziv i broj serije lijeka kako bi se uvijek mogla utvrditi veza između pacijenta i serije lijeka.

Rizik od tromboze ili diseminirane intravaskularne koagulacije postoji kod pacijenata, bilo s nasljednim ili stečenim nedostatkom, koji se liječe humanim protrombinskim kompleksom, posebno kod ponovljenih doza. Pacijente koji su primili humani protrombinski kompleks treba pažljivo promatrati zbog znakova ili simptoma intravaskularne koagulacije ili tromboze. Zbog rizika od tromboembolijskih komplikacija, pažljiv nadzor je potreban kod primjene humanog protrombinskog kompleksa kod pacijenata s koronarnom bolesti srca u anamnezi, s bolesti jetre, u peri- ili postoperativnih pacijenata, novorođenčadi ili kod pacijenata s rizikom od tromboembolijskih incidenata ili diseminiranom intravaskularnom koagulacijom. U svakoj od ovih situacija, potrebno je procijeniti potencijalnu korist liječenja naspram rizika od navedenih komplikacija.

Nema podataka o primjeni lijeka Octaplex 500 u slučaju perinatalnog krvarenja uzrokovanog nedostatkom vitamina K kod novorođenčadi.

Ovaj lijek sadrži 75 - 125 mg natrija po bočici što odgovara 3,8 - 6,3 % maksimalnog dnevnog unosa od 2 g natrija prema preporukama SZO za odraslu osobu.

Kod nasljednog nedostatka faktora ovisnih o vitaminu K, trebaju se, kada su dostupni, koristiti lijekovi sa specifičnim faktorom.

4.5. Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Lijekovi humanog protrombinskog kompleksa neutraliziraju efekat liječenja antagonistima vitamina K, no interakcije s drugim lijekovima nisu poznate.

Utjecaj na biološka ispitivanja:

Kod izvođenja ispitivanja zgrušavanja osjetljivih na heparin kod pacijenata koji primaju velike doze humanog protrombinskog kompleksa, u obzir treba uzeti heparin kao sastojak primijenjenog lijeka.

4.6. Trudnoća i dojenje

Sigurnost primjene humanog protrombinskog kompleksa u trudnoći i za vrijeme dojenja nije ustanovljena.

Ispitivanja na životinjama nisu prikladna za procjenu sigurnosti u odnosu na trudnoću, razvoj embrija ili fetusa, porođaj ili postnatalni razvoj. Humani protrombinski kompleks bi se zato tokom trudnoće i dojenja trebalo primijeniti samo ako je jasno indiciran.

4.7. Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada na mašinama

Ispitivanja uticaja na sposobnost upravljanja vozilima i rada na mašinama nisu provedena.

4.8. Neželjena dejstva

Sažetak sigurnosnog profila

Nadomjesno liječenje može dovesti do stvaranja cirkulirajućih antitijela koja inhibiraju jedan ili više humanih faktora protrombinskog kompleksa. Ako se pojave inhibitori, stanje će se manifestovati kao slab klinički odgovor.

Alergijske ili anafilaktičke reakcije mogu se javiti rijetko ($\geq 1/10\ 000$ do $< 1/1\ 000$), uključujući teške anafilaktičke reakcije.

Povećanje tjelesne temperature zabilježeno je vrlo rijetko ($< 1/10\ 000$).

Postoji rizik od tromboembolijskih epizoda nakon primjene humanog protrombinskog kompleksa (vidjeti dio 4.4.).

Tabelarna lista neželjenih reakcija lijeka Octaplex 500

Tabela prikazana u nastavku je prema MedDRA klasifikaciji sistema organa (SOC and Preferred Term Level). Učestalost neželjenih reakcija: vrlo često ($\geq 1/10$), često ($\geq 1/100$ i $< 1/10$); manje često

($\geq 1/1.000$ i $< 1/100$); rijetko ($\geq 1/10.000$ to $< 1/1.000$); vrlo rijetko ($< 1/10.000$), nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

Sistem organa MedDRA standard	Neželjena dejstva	Učestalost
Psihijatrijski poremećaji	anksioznost	Manje često
Vaskularni poremećaji	Duboka venska tromboza	Često
	Tromboza	Manje često
	Hipertenzija	Manje često
Respiratorni, torakalni i mediastinalni poremećaji	Plućna embolija	Manje često
	Bronhospazam	Manje često
	Hemoptiza	Manje često
	Epistaksa	Manje često
Opći poremećaji i promjene na mjestu primjene	žarenje na mjestu primjene	Manje često
Ispitivanja	Povećavanje fibrin D dimera	Manje često
	Povećavanje krvnog trombina	Manje često
	Nenormalna funkcija jetre	Manje često
Povrede, trovanja i proceduralne komplikacije	Tromboza u medicinskom sredstvu za primjenu lijeka	Manje često

Ova neželjena dejstva zabilježena su nakon stavljanja u promet lijaka Octaplex 500. Postmarketinško prijavljivanje neželjenih dejstava dobrovoljno i iz populacije čija je veličina nepoznata, te zbog toga nije moguće pouzdano procijeniti učestalost ovih reakcija.

<i>Poremećaji imunološkog sistema</i> Anafilaktički šok, preosjetljivost
<i>Poremećaji nervnog sistema</i> Tremor
<i>Poremećaji srca</i> Srčani arest, tahikardija
<i>Vaskularni poremećaji</i> Kolaps cirkulacije, hipotenzija
<i>Respiratorni, torakalni i mediastinalni poremećaji</i> Dispnea, respiratorno zatajenje
<i>Gastrointestinalni poremećaji</i> nauzeja
<i>Poremećaji kože i potkožnog tkiva</i> Urtikarija, osip
<i>Generalni poremećaji i reakcije na mjestu primjene</i>

Drhtavica (zimica)

Octaplex 500 sadrži heparin. Zato se rijetko može primijetiti naglo, alergijom uzrokovano, smanjenje broja trombocita ispod 100 000/ μ l ili 50% početnog broja (trombocitopenija tipa II). Kod pacijenata koji nisu prethodno bili preosjetljivi na heparin, ovo smanjenje broja trombocita može se javiti 6 - 14 dana nakon početka liječenja. Kod pacijenata koji su prethodno bili preosjetljivi na heparin, smanjenje se može javiti unutar nekoliko sati.

Liječenje lijekom Octaplex 500 mora se odmah prekinuti kod pacijenata koji razviju ovu alergijsku reakciju. Takvi pacijenti ne smiju ubuduće primati lijekove koji sadrže heparin.

Za sigurnost u vezi prenosa zaraznih agensa, vidjeti dio 4.4.

Pedijatrijska populacija

Nisu dostupni podaci o upotrebi lijeka Octaplex 500 kod pedijatrijske populacije.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijekova, a nakon stavljanja lijeka u promet, je od velike važnosti za formiranje kompletnije slike o bezbjedonosnom profilu lijeka, odnosno za formiranje što bolje ocjene odnosa korist/rizik pri terapijskoj primjeni lijeka.

Proces prijave sumnji na neželjena dejstva lijeka doprinosi kontinuiranom praćenju odnosa koristi/rizik i adekvatnoj ocjeni bezbjedonosnog profila lijeka. Od zdravstvenih stručnjaka se traži da prijave svaku sumnju na neželjeno dejstvo lijeka direktno ALMBIH. Prijava se može dostaviti:

▮ putem softverske aplikacije za prijavu neželjenih dejstava lijekova za humanu upotrebu (IS Farmakovigilansa) o kojoj više informacija možete dobiti u nasoj Glavnoj kancelariji za farmakovigilansu, ili

▮ putem odgovarajućeg obrasca za prijavljivanje sumnji na neželjena dejstva lijeka, koji se mogu naći na internet adresi Agencije za lijekove: www.almbih.gov.ba. Popunjen obrazac se može dostaviti ALMBIH putem pošte, na adresu Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, Veljka Mladenovica bb, Banja Luka, ili elektronske pošte (na e-mail adresu: ndl@almbih.gov.ba).

4.9. Predoziranje

Primjena visokih doza lijekova humanog protrombinskog kompleksa povezana je sa slučajevima srčanog infarkta, diseminirane intravaskularne koagulacije, tromboze vena i embolije pluća. Stoga je u slučaju predoziranja, rizik od razvoja tromboembolijskih komplikacija ili diseminirane intravaskularne koagulacije povećan.

5. FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1. Farmakodinamička svojstva

Octaplex 500 je biološki lijek.

Farmakoterapijska grupa: Lijekovi s djelovanjem na krv i krvotvorne organe, Antihemoragici, Faktori koagulacije krvi, ATC oznaka: B02BD01

Faktori koagulacije II, VII, IX i X, koji se sintetiziraju u jetri uz pomoć vitamina K, zajednički se nazivaju protrombinski kompleks.

Faktor VII je zimogen (proenzim) aktivnog faktora VIIa proteaze serina, kojim započinje ekstrinzični put zgrušavanja krvi. Kompleks tkivnog faktora i faktora VIIa aktivira faktore koagulacije X i IX, čime se stvaraju faktori IXa i Xa. Daljnjom aktivacijom kaskade zgrušavanja protrombin (faktor II) se aktivira i transformira u trombin. Djelovanjem trombina, fibrinogen se pretvara u fibrin, što rezultira stvaranjem ugruška. Normalno nastajanje trombina je, također, od vitalne važnosti za funkciju trombocita, kao dio primarne hemostaze.

Izolirani teški nedostatak faktora VII dovodi do smanjenog stvaranja trombina i sklonosti krvarenju zbog poremećenog stvaranja fibrina i poremećene primarne hemostaze. Izolirani nedostatak faktora IX jedna je od klasičnih hemofilija (hemofilija B). Izolirani nedostaci faktora II ili faktora X su vrlo rijetki, no u teškom obliku uzrokuju sklonost krvarenju sličnu onoj kod klasične hemofilije.

Stečeni nedostatak faktora koagulacije ovisnih o vitaminu K javlja se za vrijeme liječenja antagonistima vitamina K. Ako nedostatak postane težak, rezultat će ozbiljnom sklonošću krvarenju, okarakteriziranoj više retroperitonealnim ili cerebralnim krvarenjima nego krvarenjem u mišiće ili zglobove. Teška insuficijencija jetre, također, rezultira značajnim smanjenjem nivoa faktora koagulacije ovisnih o vitaminu K i kliničkom sklonošću krvarenju, koja je međutim često kompleksna zbog istovremenog smanjenog intravaskularnog zgrušavanja, niskog nivoa trombocita, nedostatka inhibitora zgrušavanja i poremećene fibrinolize.

Primjena humanog protrombinskog kompleksa dovodi do porasta nivoa faktora zgrušavanja ovisnih o vitaminu K, te može privremeno korigirati poremećaj zgrušavanja kod pacijenata s nedostatkom jednog ili više ovih faktora.

5.2. Farmakokinetička svojstva

Rasponi polu-života u plazmi su:

Faktori koagulacije	Polu-život
Faktor II	48 - 60 sati
Faktor VII	1,5 - 6 sati
Faktor IX	20 - 24 sata
Faktor X	24 - 48 sati

Octaplex 500 se primjenjuje u venu, te je tako trenutno raspoloživ u organizmu.

5.3. Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Pored podataka već navedenih u drugim dijelovima Sažetka, ne postoje neklinički podaci koji bi se smatrali relevantnima za kliničku sigurnost.

6. FARMACEUTSKI PODACI

6.1. Spisak pomoćnih supstanci

Prašak:

Heparin: 0,2 - 0,5 i.j./i.j. FIX

Tri natrijev citrat dihidrat

Rastvarač:

Voda za injekcije

6.2. Inkompatibilnosti

Ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima.

6.3. Rok trajanja

3 godine.

Rastvor je hemijski i fizički stabilan do 8 sati na temperaturi do +25 C.

Sa mikrobiološkog stanovišta, osim ako način otvaranja/rekonstitucije ne isključuje rizik mikrobiološke kontaminacije, lijek se mora koristiti odmah. Ako se ne koristi odmah, vrijeme i uslovi pripremljenog lijeka su pod odgovornošću korisnika.

6.4. Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Odobreno
ALMBIH
27.8.2026.

Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svjetlosti.

Za uslove čuvanja nakon rekonstitucije lijeka vidjeti 6.3.

6.5. Vrsta i sadržaj unutrašnjeg pakovanja (spremnika)

Jedno pakovanje lijeka Octaplex 500 sadrži:

- Prašak u bočici (staklo tip I) s čepom (halobutil guma) i „flip-off“ zatvaračem (aluminij)
- 20 ml vode za injekcije u bočici (staklo tip I ili tip II) s čepom (halobutil guma) i „flip off“ zatvaračem (aluminij)
- 1 Nextaro set za prijenos

6.6. Uputstva za upotrebu i rukovanje i posebne mjere za uklanjanje neiskorištenog lijeka ili otpadnih materijala koji potječu od lijeka

Pročitati sva uputstva i pažljivo ih pratiti!

Za vrijeme dole opisanog postupka, moraju se održavati aseptični uslovi!

Lijek se na sobnoj temperaturi brzo rekonstituira.

Rekonstituirani rastvor treba biti bistar ili blago opalescentan.

Ne koristiti rastvore koji su mutni ili imaju talog. Rekonstituirani lijek treba prije primjene vizualno pregledati na prisustvo čestica ili promjenu boje.

Rastvor se nakon rekonstitucije mora odmah primijeniti.

Sav neiskorišteni lijek ili otpadni materijal treba zbrinuti u skladu sa propisima za zbrinjavanje opasnog medicinskog otpada.

Uputstvo za rekonstituciju:

1. Ako je potrebno, rastvarač (voda za injekcije) i prašak, u zatvorenim bočicama, treba da postignu sobnu temperaturu. Ovu temperaturu treba održavati tokom rekonstitucije. Ako se za zagrijavanje koristi vodena kupka, mora se paziti da voda ne dođe u dodir s gumenim čepovima ili zatvaračima bočica. Temperatura vodene kupke ne bi smjela biti viša od 37°C.
2. Skinite zatvarače s bočica s praškom i vodom za injekcije, te očistite gumene čepove alkoholnim tupferom
3. Sklonite poklopac sa vanjskog pakovanja seta za prijenos Nextaro. Stavite bočicu sa rastvaračem na ravnu površinu i čvrsto je držite. Postaviti plavi dio seta za prijenos Nextaro, dok je još u vanjskom pakovanju, na vrh bočice sa rastvaračem i pritisnite prema dole dok ne klikne (slika 1). Ne zavrtati prilikom pričvršćivanja. Držeći bočicu sa rastvaračem, pažljivo uklonite vanjsko pakovanje sa seta za prijenos Nextaro, pazeći da Nextaro ostane čvrsto povezan sa bočicom sa rastvaračem (slika 2).



Slika 1

Bočica sa rastvaračem

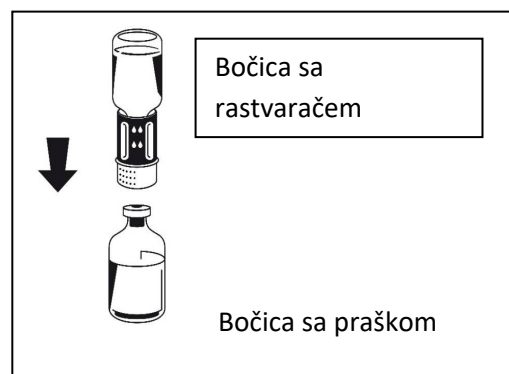


Fig. 2

Bočica sa rastvaračem

Slika 2

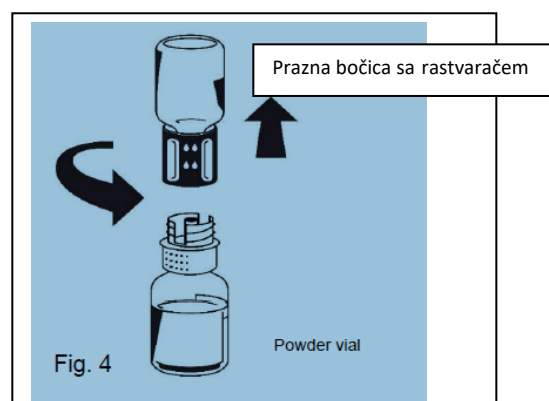
4. Postavite bočicu sa praškom na ravnu površinu i čvrsto je držite. Uzmite bočicu sa rastvaračem na koju je pričvršćen set za prijenos Nextaro i okrenite je naopako. Postavite bijeli dio seta za prijenos Nextaro na vrh bočice sa praškom i pritisnite dok ne klikne (slika 3). Nemojte zavrtati prilikom pričvršćivanja. Rastvarač automatski ulazi u bočicu sa praškom.



slika 3

5. Sa obje bočice još sastavljene lagano okrećite bočicu sa praškom dok se lijek ne rastvori. Octaplex 500 se rastvara brzo na sobnoj temperaturi u bezbojni ili plavkasti rastvor. Odvrnite (razdvojite) Nextaro na dva dijela (slika 4).

Odložite praznu bočicu od rastvarača sa plavim dijelom seta za prijenos Nextaro. Ne koristite lijek ako se prašak potpuno ne rastvori ili se stvori talog.



Uputstvo za infuziju:

Odobreno
ALMBIH
27.8.2026.

Kao mjeru opreza, trebalo bi prije i za vrijeme infuzije mjeriti brzinu pulsa pacijenta. U slučaju značajnog povećanja brzine pulsa, mora se smanjiti brzina infuzije ili prekinuti primjena lijeka.

1. Špicu od 20 ml spojite na *luer lock* priključak na bijelom dijelu seta za prijenos Nextaro. Okrenite bočicu naopako i usisajte (uvucite) rastvor u špricu. Kad je rastvor uvučen, držite klip šprice prema dole i odvojite špricu od seta za prijenos Nextaro. Odložite Nextaro i praznu bočicu.
2. Dezinficirajte mjesto primjene alkoholnim tupferom.
3. Inicirajte rastvor sporo intravenski: brzinom od 0,12 ml/kg/min (~3 jedinice/kg/min), do maksimalne brzine od 8 ml/min (~210 jedinica/min), koristeći aseptičnu tehniku.

Krv ne smije ući u špricu zbog rizika od stvaranja fibrinskih ugrušaka. Nextaro je samo za jednokratnu upotrebu.

6.7. Režim izdavanja

ZU - Lijek se izdaje na recept i primjenjuje se samo u zdravstvenoj ustanovi prilikom pružanja zdravstvenih usluga od strane zdravstvenog radnika.

7. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA (administrativno sjedište)

Octapharma AG
Seidenstrasse 2, 8853 Lachen,
Švicarska

PROIZVOĐAČ GOTOVOG LIJEKA

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges.m.b.H
Oberlaaer Strasse 235, Beč
Austrija

Octapharma S.A.S.
72 rue du Marechal Foch, 67380 Lingolsheim
Francuska

NAZIV I ADRESA NOSIOCA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Remedia d.o.o. Sarajevo
Kranjčevićeva 37
71000 Sarajevo, BiH

8. BROJ I DATUM RJEŠENJA O DOZVOLI ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Octaplex 500, prašak i rastvarač za rastvor za infuziju, ((14-38) i.j. + 25 i.j. +(9-24) i.j. + (18-30) i.j. + (13-31) i.j. + (12-32)) i.j)./ml, 20 ml rastvarača: 04-07.3-2-3342/23 od 06.12.2023. godine

DATUM REVIZIJE TEKSTA : 27.08.2026.

Odobreno
ALMBIH
27.8.2026.